INTELIGÊNCIA TERRITORIAL · PICAPS · VERSÃO 2.0

PROTOCOLO OPERACIONAL DA INTELIGÊNCIA TERRITORIAL

Guia metodológico de atuação para articular a vigilância epidemiológica tradicional e a vigilância popular em saúde, com preponderância do território

Wagner de Jesus Martins, Fernanda Machiner, Maria Eduarda Silva, Jeferson Martins de Castro



BRASÍLIA
2026

PICAPS
FIOCRUZ | Brasília
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Wagner de Jesus Martins, Fernanda Machiner, Maria Eduarda Silva, Jeferson Martins de Castro

PROTOCOLO OPERACIONAL DA INTELIGÊNCIA Tterritorial

INTELIGÊNCIA TERRITORIAL · PICAPS · VERSÃO 2.0

Guia metodológico de atuação para articular a vigilância epidemiológica tradicional e a vigilância popular em saúde, com preponderância do território

Fiocruz Brasília
Brasília
2026

AUTORIA
Wagner de Jesus Martins, Fernanda Machiner, Maria Eduarda Silva, Jeferson Martins de Castro

REALIZAÇÃO
Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz Brasília · CoLaboratório de Ciência, Tecnologia, Inovação e Sociedade (CTIS) · Plataforma de Inteligência Cooperativa com a Atenção Primária à Saúde (PICAPS)

EDIÇÃO
Versão 2.0 · Brasília, outubro de 2026

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Protocolo de Inteligência Territorial; Protocolo Operacional da Inteligência Territorial; Índice de Necessidade de Saúde (INS)

COMO CITAR
MARTINS, W. J.; MACHINER, F.; SILVA, M. E.; CASTRO, J. M. **Protocolo Operacional da Inteligência Territorial**: guia metodológico de atuação. Versão 2.0. Brasília: Fiocruz Brasília/CoLaboratório CTIS/PICAPS, 2026.

SOBRE ESTE DOCUMENTO

Este guia transforma o Protocolo de Inteligência Territorial (versão 2.0) em um modo de operar: para cada momento do trabalho, diz o que perguntar, o que fazer, quem faz, quando e como saber se deu certo. A fundamentação teórica e metodológica está no Protocolo de Inteligência Territorial, e no projeto do Índice de Necessidade de Saúde (INS), ambos na versão 2.0. O guia acompanha uma aplicação interativa que roda no navegador.

SUMÁRIO

PARTE 1 · FUNDAMENTOS DA OPERAÇÃO 9

1 Como usar este guia 10

1.1 Três compromissos que orientam toda decisão 10

1.2 Regras de ouro 10

1.3 Anatomia de cada procedimento 10

2 O método em uma imagem 11

3 Instrumentos de leitura: qual pergunta cada um responde 11

3.1 Regras de separação 12

4 Implantação: seis etapas e prontidão 12

4.1 Checklist de prontidão antes da primeira reunião deliberativa 13

PARTE 2 · O CICLO DE INTELIGÊNCIA TERRITORIAL 14

5 O Ciclo de Inteligência Territorial: cinco fases e seis ritmos 15

6 F1 · Captação de sinais (contínua) 16

6.1 Passos 16

7 F2 · Integração e análise (mensal, semestral e anual) 17

7.1 Passos 17

7.2 Quem age primeiro: o lugar e as pessoas 18

8 F3 · Interpretação e deliberação (mensal, na SCS) 19

8.1 Roteiro com perguntas por bloco (cerca de 2 horas; tempos sugeridos) 19

8.2 Matriz UIC: como priorizar 19

9 F4 · Ação e exigibilidade (48 horas a 180 dias) 20

9.1 Triagem: em qual registro de ação cada encaminhamento entra 20

9.2 Fluxo de 72 horas 21

9.3 Incorporação das invisibilidades 21

10 F5 · Reflexividade (trimestral e anual) 22

10.1 Passos trimestrais 22

10.2 Revisões de prazo mais longo 22

PARTE 3 · ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 24

11 Papéis e responsabilidades 25

12 Calendário operacional 25

12.1 Semana-tipo (sugestão; cada SCS fixa a sua) 26

13 Painel de Vigilância Integrada 26

13.1 Como ler 27

13.2 Gatilhos 27

PARTE 4 · GOVERNANÇA E SUSTENTAÇÃO 28

14 Governança em três níveis e escalonamento 29

14.1 Quando escalonar 29

15 Ameaças, sinais de alerta e contingência 30

15.1 Modo contingência (Ágora indisponível) 30

16 Aplicação interativa e parâmetros a pactuar 30

16.1 Parâmetros a pactuar no ciclo inaugural 31

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	O método em uma imagem: duas vigilâncias, um mapa, uma Sala que decide	**11**
Figura 2	Ciclo de Inteligência Territorial: cinco fases e seis ritmos	**15**
Figura 3	Matriz de leitura de sinais	**18**
Figura 4	Fluxo do alerta crítico em 72 horas	**21**
Figura 5	Governança em três níveis e subsidiariedade ascendente	**29**

LISTA DE QUADROS

Quadro 1	Anatomia de cada procedimento	10
Quadro 2	Dois instrumentos de leitura do território	12
Quadro 3	Etapas de implantação da metodologia PICAPS	12
Quadro 4	Ritmos do Ciclo de Inteligência Territorial	15
Quadro 5	Fase 1 – Captação de sinais: quem, quando, com o quê e produto	16
Quadro 6	Fase 2 – Integração e análise: quem, quando, com o quê e produto	17
Quadro 7	Quem age primeiro: o lugar e as pessoas	18
Quadro 8	Roteiro da reunião deliberativa da SCS	19
Quadro 9	Registros de ação	20
Quadro 10	Incorporação das invisibilidades aos sistemas oficiais	21
Quadro 11	Fase 5 – Reflexividade: quem, quando, com o quê e produto	22
Quadro 12	Papéis e responsabilidades no Ciclo de Inteligência Territorial	25
Quadro 13	Calendário operacional	25
Quadro 14	Semana-tipo	26
Quadro 15	Painel de Vigilância Integrada: indicadores e metas	26
Quadro 16	Situações de escalonamento	29
Quadro 17	Ameaças, sinais de alerta e contramedidas	30
Quadro 18	Módulos da aplicação interativa	30
Quadro 19	Parâmetros a pactuar no ciclo inaugural	31

LISTA DE SIGLAS

ACE	Agente de combate às endemias
ACS	Agente comunitário de saúde
APPT	Atenção Primária de Precisão Territorial
APS	Atenção Primária à Saúde
CIT	Ciclo de Inteligência Territorial
CRAS	Centro de Referência de Assistência Social
CTIS	CoLaboratório de Ciência, Tecnologia, Inovação e Sociedade
DPT	Diálogos Prospectivos Territoriais
e-SUS APS	Estratégia de informatização da Atenção Primária à Saúde
ESF	Estratégia Saúde da Família
INS	Índice de Necessidade de Saúde
INS-DF	Índice de Necessidade de Saúde, recorte distrital
INS-M	Índice de Necessidade de Saúde, recorte municipal
IRS	Índice de Resiliência Sociotécnica
IT	Inteligência Territorial
LIRAa	Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti
MTEI	Matriz de Tradução Epistêmica Intercultural
PICAPS	Plataforma de Inteligência Cooperativa com a Atenção Primária à Saúde
PVI	Painel de Vigilância Integrada
SCS	Sala de Cooperação Social
SINAN	Sistema de Informação de Agravos de Notificação
UBS	Unidade Básica de Saúde
UIC	Urgência, impacto e capacidade de agência (Matriz UIC)

PARTE 1

Fundamentos da operação

1 Como usar este guia

Este guia transforma o Protocolo de Inteligência Territorial em um modo de operar: para cada momento do trabalho, diz **o que perguntar**, **o que fazer**, **quem faz**, **quando** e **como saber se deu certo**. Sua finalidade é uma só: articular a vigilância epidemiológica tradicional e a vigilância popular em saúde de modo que o território, por meio da Sala de Cooperação Social (SCS), tenha a primeira e a última palavra sobre o que se vigia, o que os dados significam e o que se exige dos serviços.

1.1 Três compromissos que orientam toda decisão

- **Visibilização social:** o que o território sabe e os sistemas oficiais não registram precisa chegar, verificado, aos registros que orientam alocação e resposta. A cartografia social é o instrumento central.
- **Empoderamento:** fortalecer a capacidade do território de ler a própria realidade, contestar os dados que o descrevem e agir, inclusive questionando a própria PICAPS.
- **Governança participativa:** a SCS define a agenda, valida e contesta dados, delibera prioridades e cobra resposta, com prazos e registro.

1.2 Regras de ouro

1. **Nada sem a SCS.** Nenhuma decisão sobre dados ou ações do território sem deliberação na Sala pela comunidade.
2. **O dado informa; na Sala se decide.** Um valor alto no INS ou um sinal no Painel gera uma pergunta para a SCS, nunca uma ação automática.
3. **Dois fluxos, um mapa.** Alertas populares e registros oficiais são sempre lidos juntos, sobre o mapa da cartografia social, no contexto do INS.
4. **Todo alerta crítico tem resposta registrada em até 72 horas**, inclusive a ausência de resposta.
5. **Toda invisibilidade verificada vira registro oficial.**
6. **Medir não é deliberar.** O INS tem pesos fixos; o território decide o que fazer com ele.
7. **Devolver antes de publicar.** O território conhece os resultados antes de gestores, academia ou financiadores.
8. **Resolver no nível mais próximo**, e sempre com plano B se a Plataforma Ágora estiver indisponível.

1.3 Anatomia de cada procedimento

Quadro 1 – Anatomia de cada procedimento

ELEMENTO	O QUE RESPONDE
Pergunta-guia	Que pergunta o grupo precisa responder neste momento
Passos	O que fazer, em ordem
Quem e quando	Responsável, apoio e prazo
Com o quê	Instrumentos e fontes de dados
Produto	O que precisa existir ao final
Sinal de alerta	Como perceber que o procedimento está falhando
Erros a evitar	Armadilhas recorrentes de raciocínio ou de prática

2 O método em uma imagem

Todo o protocolo cabe neste fluxo: os sinais da vigilância popular e da tradicional são postos no mesmo mapa; na Sala de Cooperação Social a comunidade lê, contesta e decide; os serviços e a gestão respondem; e tudo volta à Sala.

Figura 1 – O método em uma imagem: duas vigilâncias, um mapa, uma Sala que decide



Quatro produtos mostram que a articulação funcionou:

1. **Resposta** aos alertas;
2. **Programação** dos serviços ajustada às prioridades do território;
3. **Visibilização** do que os sistemas não viam, e
4. **Exigibilidade** junto à gestão.

Se nenhum deles aparece, o ciclo está produzindo dados, não inteligência.

3 Instrumentos de leitura: qual pergunta cada um responde

Dois instrumentos sustentam a leitura do território, sempre sobre o mapa da cartografia social. Cada um responde a uma pergunta diferente e um não se soma ao outro; usar um no lugar do outro é o erro de raciocínio mais comum.

Quadro 2 – Dois instrumentos de leitura do território

	INS	PAINEL DE VIGILÂNCIA INTEGRADA (PVI)
Pergunta	Onde a necessidade de saúde é maior?	O que as duas vigilâncias sinalizam e o que foi feito?
Escala	Município (INS-M) e Região Administrativa (INS-DF)	Microárea e território da SCS
Mede	Necessidade potencial de cuidado (11 indicadores)	Sinais, convergência, visibilização e resposta (9 indicadores, não agregados)
Ritmo	Anual	Mensal (V5 e V8 trimestrais)
Use para	Escolher territórios de implantação; reivindicar recursos	Conduzir a reunião mensal; cobrar resposta; avaliar a articulação
Não use para	Comparar áreas dentro do território	Medir vulnerabilidade ou necessidade

Dentro do território, onde olhar primeiro é lido no **mapa da cartografia social**: áreas de risco, pontos críticos, domicílios e famílias fora dos cadastros e prioridades do Plano Popular, sobre os quais alertas e registros oficiais são georreferenciados por microárea.

3.1 Regras de separação

- **Dados da intervenção ficam no Painel.** Alertas, reuniões, respostas e participação não entram no INS, porque sua variação reflete a atividade da SCS e seria confundida com mudança no território.
- **Morbimortalidade e oferta ficam fora do índice.** Doenças e óbitos servem para validar o INS e aparecem como sinais no Painel; cobertura de serviços é lida à parte, na análise de lacunas.
- **Pesos fixos.** O INS tem pesos fixos em cada versão. A participação do território entra na cartografia social, na verificação territorial e na deliberação; a Matriz UIC prioriza problemas, não pondera indicadores.
- **Do INS ao mapa.** O INS-DF diz quais Regiões Administrativas têm maior necessidade; dentro delas, a cartografia social mostra onde olhar primeiro.

4 Implantação: seis etapas e prontidão

O ciclo de operação só começa depois que a metodologia PICAPS foi implantada no território, em seis etapas encadeadas. Cada etapa tem uma pergunta que precisa estar respondida antes de passar à seguinte.

Quadro 3 – Etapas de implantação da metodologia PICAPS

ETAPA	PERGUNTA QUE PRECISA ESTAR RESPONDIDA	PRODUTO	INCLUI
1. Ativação das redes sociotécnicas	Quem, no território, precisa estar na mesa, e quem costuma ficar de fora?	Mapa sociométrico; pacto dialógico	Lideranças, coletivos, segmentos sub-representados
2. Diagnóstico multidimensional	O que os dados oficiais dizem deste território e o que não dizem?	Dimensões 1 a 4 dos DPT; leitura do INS	Primeira lista de invisibilidades estatísticas
3. Cartografia social	O que o território sabe que os mapas oficiais não mostram?	Mapa do território vivido (início da Dimensão 5)	Áreas de risco, pontos críticos e domicílios fora dos cadastros a verificar

ETAPA	PERGUNTA QUE PRECISA ESTAR RESPONDIDA	PRODUTO	INCLUI
4. Plano Popular	O que vamos vigiar, com que prioridade e o que exigiremos?	Plano Popular (fim da Dimensão 5)	Agenda das duas vigilâncias no território
5. Formação	Quem vai observar, registrar e interpretar, e quem vai receber nos serviços?	Pesquisadores populares formados; equipes preparadas	Equipes de APS e de vigilância, não só moradores
6. Instalação da SCS	Por onde o alerta passa e quem responde?	Sala em operação; fluxos pactuados	Interlocutores nomeados na UBS e na vigilância

4.1 Checklist de prontidão antes da primeira reunião deliberativa

- ☐ Agenda de vigilância do Plano Popular aprovada (agravos e condições prioritários)
- ☐ Categorias de alerta da Plataforma Ágora ajustadas à agenda
- ☐ Interlocutor nomeado na UBS de referência e na vigilância em saúde
- ☐ Prazos de resposta pactuados por escrito (72 horas para alertas críticos)
- ☐ Fluxo de cruzamento de dados definido no ambiente seguro da secretaria, com saída agregada por microárea
- ☐ Mapa da cartografia social disponível, com áreas de risco, pontos críticos e prioridades do Plano Popular por microárea
- ☐ Dupla de Facilitação definida e segmentos comunitários convidados
- ☐ Formulários físicos de contingência impressos

> **SINAL DE ALERTA**
> Sem interlocutor nomeado no serviço, a vigilância popular não tem para onde ir. Não inicie o ciclo sem ele.

PARTE 2

O Ciclo de Inteligência Territorial

5 O Ciclo de Inteligência Territorial: cinco fases e seis ritmos

O Ciclo de Inteligência Territorial (CIT) é o modo de operar do protocolo. Cada fase começa por uma pergunta, e a pergunta vem antes do procedimento: quem conduz a fase deve saber responder à pergunta ao final dela.

Figura 2 – Ciclo de Inteligência Territorial: cinco fases e seis ritmos



A única exceção à ordem das fases é o alerta crítico, que salta da captação para a ação em 72 horas; ainda assim, ele volta à Sala na reunião seguinte, com a resposta registrada ou a falta dela.

Quadro 4 – Ritmos do Ciclo de Inteligência Territorial

RITMO	O QUE ACONTECE	FASE
Contínuo	Registro de alertas e da cartografia; fluxo de 72 horas	F1, F4
Semanal	Revisão dos alertas e destaque dos críticos; carga dos registros oficiais; conferência de prazos	F1, F4
Mensal	Cruzamento dos fluxos e PVI; reunião deliberativa; encaminhamentos e incorporações	F2, F3, F4
Trimestral	Prioridades do ciclo e programação das equipes (APPT); IRS; Relatório de Ciclo; Dimensões 2 e 3 dos DPT	F3, F4, F5
Semestral	Seminário de rede; Dimensão 4 dos DPT	F2, F5
Anual	INS; revisão do Plano Popular e do currículo; relatório técnico após devolução	F2, F5

6 F1 · Captação de sinais (contínua)

> **PERGUNTA-GUIA**
> *O que está acontecendo no território agora, segundo quem vive nele e segundo os registros oficiais?*

Quadro 5 – Fase 1 – Captação de sinais: quem, quando, com o quê e produto

ELEMENTO	DEFINIÇÃO
Quem	Pesquisadores populares (fluxo popular); equipes de APS e de vigilância (fluxo tradicional); supervisor de campo (revisão semanal); técnico de dados (carga)
Quando	Contínuo; revisão às segundas; carga oficial semanal
Com o quê	Plataforma Ágora; SINAN; e-SUS APS; LIRAa e alertas da Defesa Civil como camada de contexto
Produto	Alertas e registros oficiais sobre o mesmo mapa da cartografia social; alertas críticos encaminhados

6.1 Passos

1. **Observar e registrar.** O pesquisador popular registra o alerta na Ágora no momento em que observa: categoria, local georreferenciado, data e hora, descrição e urgência. Se o evento não cabe em nenhuma categoria, registra como "não previsto".
2. **Classificar a urgência.** Urgência máxima dispara na hora o fluxo de 72 horas (F4). As demais entram na análise mensal.
3. **Atualizar a cartografia social** quando o território identifica nova área de risco, ponto crítico ou família fora dos cadastros; esses casos vão para a lista de verificação.
4. **Carregar o fluxo tradicional.** Notificações e cadastros nominais ficam no ambiente seguro da secretaria; à Ágora chegam só contagens por microárea e semana.
5. **Revisar semanalmente.** O supervisor de campo confere os alertas da semana, devolve os incompletos e destaca os críticos para a Dupla de Facilitação.

> **SINAL DE ALERTA**
> Queda de alertas numa microárea com área de risco ou prioritária mapeada, ou pesquisadores populares sem registro no mês (V9 baixo). Silêncio pode ser ausência de problema ou ausência de observação.

Erros a evitar

- Esperar a reunião para registrar um evento.
- Descartar o que não cabe nas categorias: o "não previsto" é o que ensina o sistema.
- Trazer dados nominais de saúde para a Ágora ou para a reunião.
- Ler o número de alertas como medida de gravidade: mais alertas podem significar mais problemas, mais observação ou ambos.

7 F2 · Integração e análise (mensal, semestral e anual)

> **PERGUNTA-GUIA**
> *Onde as duas vigilâncias convergem, onde divergem, o que nenhuma registra, e em que lugar do mapa do território isso acontece?*

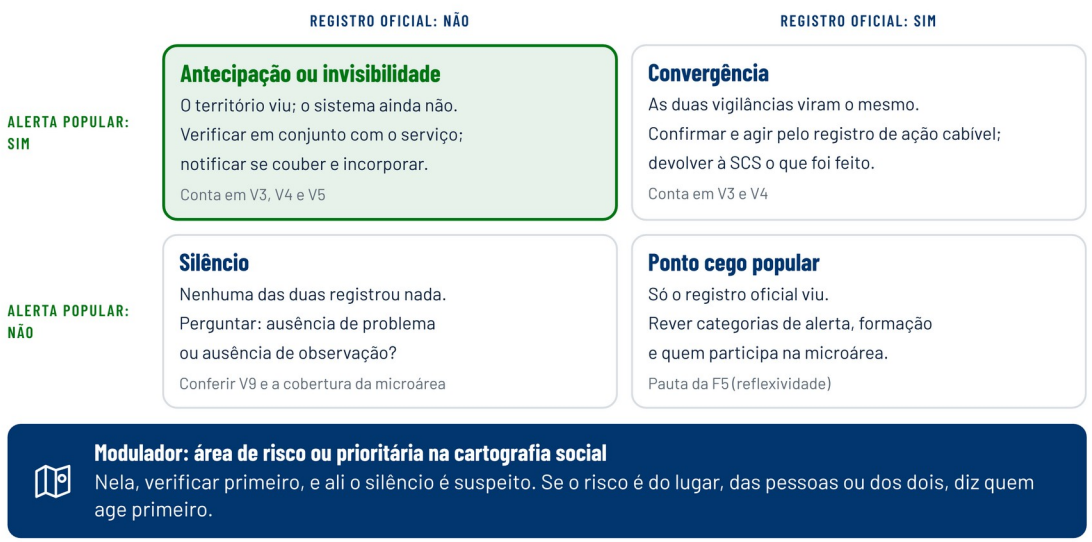
Quadro 6 – Fase 2 – Integração e análise: quem, quando, com o quê e produto

ELEMENTO	DEFINIÇÃO
Quem	Técnico de dados do CTIS (executa); equipe de Vigilância em Saúde (valida a leitura epidemiológica); supervisor de campo (dimensões dos DPT); pesquisadores populares (relatos sistematizados)
Quando	Mensal, com entrega à Dupla de Facilitação antes da reunião; INS anual
Com o quê	Ambiente seguro da secretaria de saúde (cruzamento nominal); Plataforma Ágora (só contagens agregadas); mapa da cartografia social; PVI; DPT
Produto	Relatório de dados em linguagem legível; mapa atualizado; lista de convergências, antecipações, divergências e invisibilidades; lista de verificação

7.1 Passos

1. **Cruzar no ambiente seguro.** Parear alertas populares e notificações por microárea, categoria compatível e janela de tempo. Para fora do ambiente seguro saem apenas contagens por microárea e semana.
2. **Classificar cada sinal na matriz de leitura** (abaixo): convergência, antecipação ou invisibilidade, ponto cego popular ou silêncio.
3. **Situar no mapa.** Para cada sinal, anotar se cai em área de risco ou prioritária mapeada na cartografia social e se o risco é do lugar, das pessoas ou dos dois.
4. **Calcular o PVI do mês** (V1 a V4, V6, V7, V9; V5 e V8 no fechamento do trimestre) e comparar com metas e gatilhos. V4 sempre com o valor esperado ao acaso ao lado.
5. **Montar a lista de verificação** com as antecipações e invisibilidades a confirmar em campo, com o serviço responsável por cada uma.
6. **Escrever o relatório como perguntas para a SCS**, não como conclusões: "nesta microárea com área de risco mapeada, três alertas de alagamento sem registro da Defesa Civil: o que sabemos?".
7. **No ano**, atualizar o INS; incorporações que corrigem registros oficiais são tratadas como revisão de medida, e não como mudança do território.

Figura 3 – Matriz de leitura de sinais



A célula destacada é onde nasce a visibilização social: o que o território vê e o sistema ainda não registra não é descartado nem aceito sem exame; vai para verificação conjunta e, confirmado, para o registro oficial.

7.2 Quem age primeiro: o lugar e as pessoas

Antes de levar um ponto do mapa à SCS, leia na cartografia social e nos cadastros se o risco é sobretudo do lugar, das pessoas ou dos dois. Isso orienta quem age primeiro.

Quadro 7 – Quem age primeiro: o lugar e as pessoas

SITUAÇÃO MAPEADA	O QUE INDICA	QUEM AGE PRIMEIRO	TIPO DE AÇÃO A DISCUTIR NA SCS
Risco do lugar e das pessoas	Dano mais provável: o lugar e as pessoas	APS, vigilância e Defesa Civil, juntas	Prioridade do ciclo; busca ativa e advocacy de infraestrutura
Risco do lugar	Área de risco, saneamento precário, criadouros	Defesa Civil, vigilância ambiental, saneamento	Intervenção sobre o lugar (drenagem, contenção de encosta, saneamento); advocacy
Risco das pessoas	Crianças pequenas, idosos, famílias sem renda ou fora dos cadastros	Equipe de APS e CRAS	Proteção às pessoas: busca ativa de crianças de 0 a 4 anos e idosos de 75 anos ou mais; Cadastro Único
Nenhum risco mapeado	Nada registrado na cartografia nem nos sistemas	—	Acompanhar e perguntar se há invisibilidades que o mapa ainda não mostra

SINAL DE ALERTA

Relatório entregue no dia da reunião; lista de invisibilidades vazia por vários meses; V4 apresentado sem o valor esperado ao acaso.

Erros a evitar

- Tratar divergência como erro de uma das vigilâncias, em vez de pergunta a investigar.
- Usar o INS para comparar áreas dentro do território.
- Somar o PVI ao INS, ou levar alertas e respostas para dentro do índice.
- Ler as incorporações aos registros oficiais como piora ou melhora do território: é revisão de medida.
- Levar à SCS conclusões prontas: o relatório prepara a deliberação, não a substitui.

8 F3 · Interpretação e deliberação (mensal, na SCS)

> **PERGUNTA-GUIA**
> *O que esses sinais significam para nós, o que priorizamos e o que vamos exigir?*

A reunião mensal é onde se exerce a preponderância do território. A Dupla de Facilitação conduz; os pesquisadores populares são protagonistas; profissionais de APS e de vigilância trazem a perspectiva clínica, epidemiológica e de gestão e levam as prioridades para suas equipes.

8.1 Roteiro com perguntas por bloco (cerca de 2 horas; tempos sugeridos)

Quadro 8 – Roteiro da reunião deliberativa da SCS

BLOCO	TEMPO	PERGUNTA QUE O BLOCO RESPONDE	PRODUTO
1. Abertura	10 min	Quem está aqui e quem falta?	Presença por segmento
2. Retorno	15 min	O que aconteceu com cada encaminhamento anterior, inclusive os sem resposta?	Situação de cada encaminhamento
3. Leitura do mapa	20 min	Onde estão os sinais das duas vigilâncias, e em que áreas do mapa da cartografia social?	Leitura do território, começando pelos pesquisadores populares
4. Convergências e divergências	20 min	O que as duas vigilâncias viram juntas, o que só uma viu, que dado oficial contestamos?	Contestações e invisibilidades registradas
5. Priorização (Matriz UIC)	30 min	O que é mais urgente, de maior impacto e sobre o que temos mais capacidade de agir?	Prioridades do mês
6. Encaminhamentos	15 min	Quem faz o quê, até quando, por qual registro de ação?	Encaminhamentos com prazo
7. Ata	10 min	Todos reconhecem o que foi decidido?	Ata assinada

8.2 Matriz UIC: como priorizar

Cada problema (e não cada indicador) recebe nota de 1 a 5 em três critérios: **Urgência** (quanto tempo podemos esperar?), **Impacto** (quanto afeta a vida e a saúde das famílias?) e **Capacidade de agência** (quanto o território e os serviços locais conseguem agir sobre isso?). A soma ordena a discussão, mas não a substitui: a plenária pode reordenar, desde que registre o motivo em ata. Problema de baixa capacidade de agência e alto impacto é candidato a advocacy, e não a ser descartado.

> **SINAL DE ALERTA**
> Técnicos falam mais que pesquisadores populares; nenhuma contestação registrada por vários meses; encaminhamentos sem responsável ou sem prazo.

Erros a evitar

- Deixar o número decidir: um INS alto ou um aumento de notificações gera uma pergunta, não uma ação automática.
- Pular o retorno dos encaminhamentos: sem ele, o território deixa de acreditar que alertar adianta.
- Usar a Matriz UIC para mudar pesos do índice.
- Tratar divergência como erro de um dos lados, em vez de pergunta a investigar.

9 F4 · Ação e exigibilidade (48 horas a 180 dias)

> **PERGUNTA-GUIA**
> *Quem responde, o quê, até quando, e o que fazemos se não responderem?*

9.1 Triagem: em qual registro de ação cada encaminhamento entra

Para cada encaminhamento, responda às perguntas na ordem. A primeira resposta "sim" define o registro.

1. **Há risco à vida ou à saúde nas próximas horas?** → Resposta imediata.
2. **É algo que o território viu, o sistema não registra, e a verificação conjunta confirmou?** → Incorporação.
3. **Os serviços locais conseguem agir com o que têm?** → Ação planejada.
4. **Exige decisão, recurso ou política fora do alcance local?** → Advocacy.

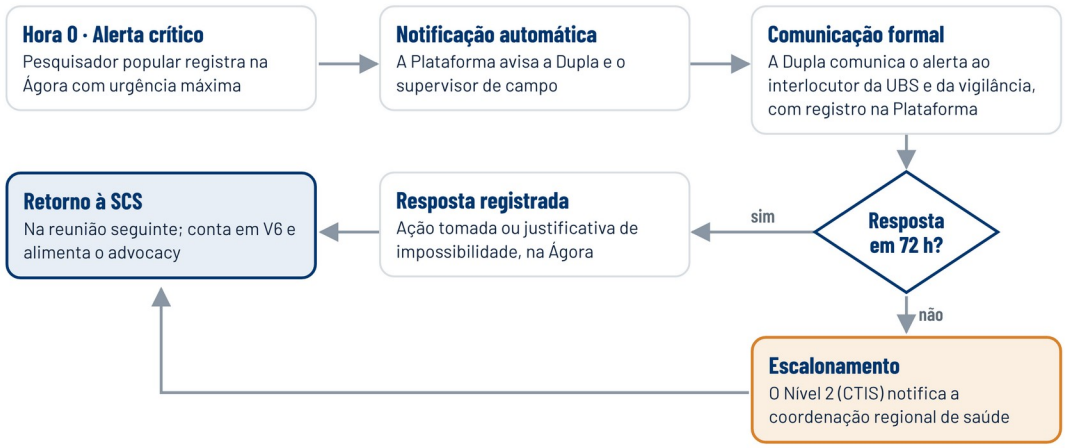
Quadro 9 – Registros de ação

REGISTRO	PRAZO	O QUE INCLUI	ACIONA	CONTA NO PVI
Resposta imediata	48 a 72 horas	Alertas críticos	UBS de referência e vigilância em saúde, diretamente	V6
Incorporação	Até a reunião seguinte	Invisibilidades verificadas	Serviço responsável pelo registro oficial (Quadro 10)	V5
Ação planejada	30 a 90 dias	Itens do Plano Popular e prioridades do ciclo	Responsáveis da ata; programação das equipes (APPT)	V7, V8
Advocacy	90 a 180 dias	Encaminhamentos que exigem decisão institucional	Gestão pública, pelos Níveis 2 e 3, com INS, cartografia social e histórico de respostas	V7

Todo encaminhamento sai da ata com responsável, prazo e registro. A falta de resposta também é registrada: é o principal insumo do advocacy.

9.2 Fluxo de 72 horas

Figura 4 – Fluxo do alerta crítico em 72 horas



O prazo corre a partir da hora zero, e não da reunião. O escalonamento não substitui a resposta: ele torna visível, na instância seguinte, que ela não veio.

9.3 Incorporação das invisibilidades

É a forma operacional da visibilização social: o que o território revela e o serviço confirma em verificação conjunta passa a constar do registro oficial.

Quadro 10 – Incorporação das invisibilidades aos sistemas oficiais

O TERRITÓRIO IDENTIFICA	VERIFICAÇÃO CONJUNTA	QUEM INCORPORA	ONDE PASSA A CONSTAR
Domicílios ou famílias não cadastrados	Visita do ACS com o pesquisador popular	Equipe de APS	Cadastro do e-SUS APS
Área de alagamento, enxurrada ou deslizamento fora do mapa oficial	Vistoria da Defesa Civil com a SCS	Defesa Civil	Camada de áreas de risco
Criadouros, depósitos e pontos críticos de vetores	Inspeção do ACE	Vigilância ambiental	Roteiro de pontos estratégicos e de visitas
Evento compatível com agravo de notificação compulsória	Avaliação clínica ou epidemiológica	Equipe de APS ou de vigilância	SINAN
Famílias de baixa renda fora do Cadastro Único	Encaminhamento ao CRAS	Gestão do Cadastro Único	Cadastro Único

Cada incorporação recebe marca de origem e é devolvida à SCS na reunião seguinte. Quando corrige um registro oficial, é **revisão de medida**: a área de risco reconhecida hoje existia antes, e a correção não pode aparecer como piora do território.

> **SINAL DE ALERTA**
> V6 abaixo de 80%; encaminhamentos que voltam à pauta sem retorno por duas reuniões; lista de verificação parada.

Erros a evitar

- Descartar problema de alto impacto e baixa capacidade de agência: ele é candidato a advocacy.
- Executar ação planejada fora da programação das equipes: sem APPT, ela não se sustenta.
- Registrar só as respostas recebidas e apagar as que não vieram.
- Incorporar sem verificação conjunta, ou verificar e não devolver à SCS.

10 F5 · Reflexividade (trimestral e anual)

> **PERGUNTA-GUIA**
> *O que as duas vigilâncias viram juntas, o que só uma viu e o que nenhuma viu?*

Quadro 11 – Fase 5 – Reflexividade: quem, quando, com o quê e produto

ELEMENTO	DEFINIÇÃO
Quem	SCS e pesquisadores populares (autores do Relatório de Ciclo); supervisor de campo (coordenação); técnico de dados; Coordenação do CTIS
Quando	Trimestral (Relatório de Ciclo); anual (Plano Popular, currículo, cartografia social, relatório técnico)
Com o quê	Painel acumulado do trimestre; atas; lista de divergências e invisibilidades; IRS
Produto	Relatório de Ciclo; categorias de alerta e agenda revistas; currículo atualizado

10.1 Passos trimestrais

1. **Onde a articulação funcionou?** Convergências (V3), antecipações (V4), respostas no prazo (V6, V7) e prioridades incorporadas pelas equipes (V8).
2. **Onde falhou?** Alertas sem verificação, alertas críticos sem resposta, divergências que ninguém investigou.
3. **O que ninguém viu?** Eventos que chegaram ao serviço sem nenhum alerta prévio, ou que o território conhecia e não registrou.
4. **O que muda no próximo ciclo?** Categorias de alerta, agenda de vigilância, formação e fluxos com os serviços.
5. **Escrever o Relatório de Ciclo.** Os pesquisadores populares redigem a síntese do que o território aprendeu sobre si; o relatório alimenta a ciência, a gestão e a formação.

10.2 Revisões de prazo mais longo

- **Anual:** revisão do Plano Popular e da cartografia social; atualização do currículo; relatório técnico à gestão somente depois da devolução à SCS.
- **IRS:** a sociometria da rede (coesão, diversidade, atividade) apoia a reflexão sobre a capacidade coletiva, fora do Painel e do INS.

> **SINAL DE ALERTA**
> Relatório de Ciclo escrito pela equipe técnica, e não pelos pesquisadores populares; trimestre sem nenhuma revisão de categorias ou de fluxos.

Erros a evitar

- Avaliar só o volume de atividade (quantos alertas, quantas reuniões) e não a articulação.
- Ler as incorporações aos registros oficiais como mudança do território (é revisão de medida).

PARTE 3

Organização e acompanhamento

11 Papéis e responsabilidades

Sete atores operam o ciclo. Cada um é dono de pelo menos uma entrega (●●●); a equipe de Vigilância em Saúde está no ciclo porque, sem ela, a vigilância popular não encontra a tradicional.

Quadro 12 – Papéis e responsabilidades no Ciclo de Inteligência Territorial

ATOR	F1	F2	F3	F4	F5	O QUE É SÓ DELE
Pesquisadores populares	●●●	●	●●●	●●	●●	Registrar alertas e atualizar a cartografia; protagonizar a deliberação; participar da verificação; escrever o Relatório de Ciclo
Dupla de Facilitação da SCS	●●	●	●●●	●●	●●	Conduzir a reunião e a MTEI; assinar atas; comunicar os serviços; acompanhar prazos
Equipes de APS (ESF e ACS)	●●	●	●●	●●●	●	Manter o cadastro; responder encaminhamentos; cadastrar domicílios não registrados; incorporar prioridades à programação (APPT)
Equipe de Vigilância em Saúde (epidemiológica, ambiental, ACE)	●●	●●	●●	●●●	●	Manter notificações e LIRAa; investigar alertas compatíveis com agravos; incluir pontos críticos no roteiro dos ACE; responder em 72 horas
Técnico de dados do CTIS	●	●●●	●	—	●●	Cruzar os dois fluxos no ambiente seguro; calcular o Painel e o INS; preparar o relatório de dados
Supervisor de campo do CTIS	●●	●	●●	●	●●●	Revisão semanal de alertas; acompanhamento dos críticos; coordenação da reflexividade
Coordenação do CTIS	—	—	—	●●	●●●	Escalonamento (Nível 2); publicações após devolução; interface com a gestão

●●● responsável primário · ●● compartilhado · ● apoio · — não atua

12 Calendário operacional

O ciclo roda em seis ritmos encaixados: o contínuo alimenta o semanal, que alimenta o mensal, e assim por diante.

Quadro 13 – Calendário operacional

RITMO	O QUE ACONTECE (FASE)	PRODUTO	RESPONSÁVEL PRINCIPAL
Contínuo	Registro de alertas e atualização da cartografia (F1); fluxo de 72 horas (F4)	Alertas no mapa; respostas registradas	Pesquisadores populares; serviços
Semanal	Revisão dos alertas e destaque dos críticos (F1); carga dos registros oficiais (F1); conferência de prazos (F4)	Lista de críticos; contagens por microárea	Supervisor; técnico de dados; Dupla
Mensal	Cruzamento dos fluxos e Painel (F2); reunião deliberativa (F3); encaminhamentos e incorporações (F4)	Relatório de dados; ata; respostas	Técnico de dados; Dupla; serviços
Trimestral	Prioridades e programação das equipes (F3, F4); Relatório de Ciclo (F5); Dimensões 2 e 3 dos DPT (F2)	Relatório de Ciclo; programação ajustada (APPT)	SCS; equipes de APS e vigilância

RITMO	O QUE ACONTECE (FASE)	PRODUTO	RESPONSÁVEL PRINCIPAL
Semestral	Seminário de rede das SCS (F5); Dimensão 4 dos DPT (F2)	Ata do seminário; Dimensão 4 revista	Supervisor de campo; Coordenação
Anual	Atualização do INS (F2); revisão do Plano Popular, da cartografia social e do currículo; relatório técnico após devolução (F5)	INS; Plano Popular e mapa revistos	Coordenação; SCS

12.1 Semana-tipo (sugestão; cada SCS fixa a sua)

Quadro 14 – Semana-tipo

DIA	ROTINA
Todos os dias	Registro de alertas; críticos disparam o fluxo de 72 horas
Segunda-feira	Supervisor revisa os alertas da semana anterior e destaca os críticos
Quarta-feira	Dupla confere os prazos dos encaminhamentos abertos
Sexta-feira	Técnico de dados carrega as contagens oficiais e atualiza o mapa

13 Painel de Vigilância Integrada

Nove indicadores, todos de fontes que já existem na rotina do ciclo, respondem a quatro perguntas: o que cada vigilância sinaliza, se elas se reforçam, se o invisível passou a constar e se os serviços respondem. Não são agregados e não medem vulnerabilidade.

Quadro 15 – Painel de Vigilância Integrada: indicadores e metas

CÓD.	PERGUNTA	INDICADOR	FONTE E RITMO	MÍNIMA	RECOMENDADA
SINAIS DAS DUAS VIGILÂNCIAS					
V1	O que o território sinaliza?	Alertas por 1.000 habitantes, por categoria e microárea	Ágora; mensal	sem meta	sem meta
V2	O que os serviços registram?	Casos dos agravos prioritários por microárea; canal endêmico por área de UBS	SINAN; mensal	sem meta	sem meta
ARTICULAÇÃO ENTRE AS VIGILÂNCIAS					
V3	O alerta se confirma?	Coorte de alertas de três meses antes: verificados e, entre eles, confirmados	Ágora × SINAN/e-SUS (ambiente seguro); mensal	80% verificados; 40% confirmados	95%; 60%
V4	O território antecipa?	Casos de agravos agudos precedidos, em 30 dias e na mesma microárea, por alerta compatível; com o esperado ao acaso	SINAN × Ágora (ambiente seguro); mensal	30% e acima do acaso	50%
V5	O invisível passou a constar?	Invisibilidades verificadas e incorporadas aos sistemas, por tipo	Atas e registros; trimestral	1 por trimestre	tendência crescente
RESPOSTA E GOVERNANÇA					

CÓD.	PERGUNTA	INDICADOR	FONTE E RITMO	MÍNIMA	RECOMENDADA
V6	O serviço responde ao alerta crítico?	Alertas críticos com resposta em até 72 horas; tempo mediano	Ágora; mensal	80%	95%
V7	A gestão responde à Sala?	Encaminhamentos com resposta dentro do prazo do registro	Atas e Ágora; mensal	60%	80%
V8	A Sala muda a rotina dos serviços?	Prioridades da SCS na programação trimestral das equipes (APPT)	Atas e programação; trimestral	50%	75%
PARTICIPAÇÃO					
V9	Quem participa?	Pesquisadores ativos no mês (% dos formados); segmentos na reunião	Ágora e presença; mensal	50% e 2	70% e 4

Metas propostas, a pactuar na SCS e com a gestão no ciclo inaugural.

13.1 Como ler

- **V1 e V2 não têm meta.** São lidos juntos, sobre o mapa da cartografia social, com a matriz de leitura de sinais (F2).
- **Confirmação baixa entre alertas verificados** pede revisão de categorias e formação; **muitos alertas não verificados** indicam falha do serviço, e não da vigilância popular.
- **V6 a V8 medem a exigibilidade:** se o território é ouvido. Sem eles, a vigilância popular pode registrar muito e não mudar nada.

13.2 Gatilhos

- Indicador de V3 a V9 abaixo da mínima por **dois períodos seguidos** → supervisor examina e leva à SCS com proposta de correção.
- **V6 abaixo da mínima por dois meses** → aciona o Nível 2 de governança com o histórico de alertas sem resposta.
- **Dois ou mais indicadores do mesmo bloco** abaixo da mínima → o bloco vira pauta prioritária do Relatório de Ciclo.

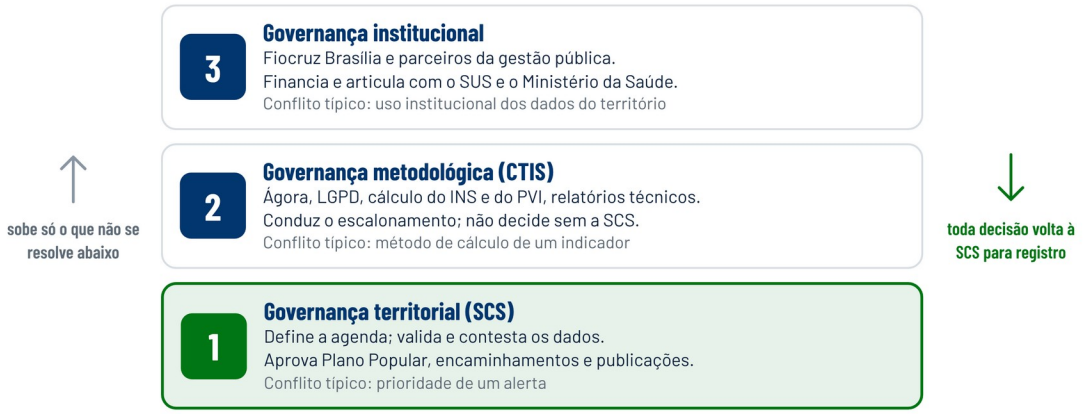
PARTE 4

Governança e sustentação

14 Governança em três níveis e escalonamento

A preponderância do território tem forma institucional: a SCS é a instância primária, e nenhuma decisão sobre dados ou ações territoriais é tomada sem ela. Os níveis de cima existem para sustentar e cobrar, não para decidir no lugar do território.

Figura 5 – Governança em três níveis e subsidiariedade ascendente



O desenho se lê de baixo para cima: o que se resolve na SCS não sobe; o que sobe volta à SCS com a decisão tomada.

14.1 Quando escalonar

Quadro 16 – Situações de escalonamento

SITUAÇÃO	QUEM RESOLVE	O QUE LEVA
Divergência sobre a prioridade de um alerta	Nível 1, na reunião	Matriz UIC e motivo registrado em ata
Alerta crítico sem resposta em 72 horas	Nível 2 notifica a coordenação regional de saúde	Registro do alerta e da comunicação formal
V6 abaixo da meta mínima por dois meses consecutivos	Nível 2	Histórico de alertas sem resposta
Indicador de V3 a V9 abaixo da meta mínima por dois períodos consecutivos	Supervisor de campo leva à SCS	Proposta de correção
Dois ou mais indicadores do mesmo bloco abaixo da meta mínima	SCS, no Relatório de Ciclo	Pauta prioritária do trimestre
Discordância sobre o método de cálculo de um indicador	Nível 2, com devolução à SCS	Ficha técnica e metaindicadores
Encaminhamento que exige decisão institucional	Níveis 2 e 3, por advocacy (90 a 180 dias)	INS, cartografia social e histórico de respostas
Disputa sobre o uso institucional dos dados do território	Nível 3	Autorização da SCS e termos de uso

Regra que não se escalona: devolver antes de publicar. Nenhum resultado chega à gestão, à academia ou a financiadores antes de ter sido apresentado e discutido na SCS.

15 Ameaças, sinais de alerta e contingência

Quatro ameaças recorrentes podem esvaziar a articulação. Cada uma tem um sinal que aparece antes do colapso e uma contramedida definida.

Quadro 17 – Ameaças, sinais de alerta e contramedidas

AMEAÇA	SINAL DE ALERTA	CONTRAMEDIDA	QUEM ACIONA
Fadiga participativa	Queda de V9; mesmas pessoas em todas as tarefas	Ajuda de custo; distribuir a carga; autonomia progressiva	Supervisor de campo e Coordenação
Captura tecnocrática	Técnicos falam mais que pesquisadores populares; poucas contestações em ata	Pesquisadores falam primeiro em cada bloco; nenhum dado vira ação sem deliberação	Dupla de Facilitação
Desconexão entre IT e ação	Queda de V6, V7 ou V8	Escalonamento ao Nível 2; devolver à SCS o destino de cada encaminhamento; advocacy com histórico de respostas	Dupla e Nível 2
Dependência tecnológica	Plataforma Ágora indisponível	Modo contingência (abaixo)	Técnico de dados

15.1 Modo contingência (Ágora indisponível)

- ☐ Avisar a SCS e os pesquisadores populares que o modo contingência está ativo
- ☐ Usar formulários físicos equivalentes (local, data e hora, categoria, urgência)
- ☐ Alertas críticos: a Dupla comunica a UBS e a vigilância diretamente, mantendo as 72 horas
- ☐ Reunião com mapa e Painel impressos do último mês disponível
- ☐ Ao voltar o sistema: digitar os formulários e marcar o período como "contingência"

16 Aplicação interativa e parâmetros a pactuar

O guia tem uma versão interativa, a aplicação do Protocolo de Inteligência Territorial, publicada em jefersonunb.github.io/protocolo-inteligencia-territorial. Ela roda no navegador, inclusive no celular e sem instalação, e guarda os registros apenas no aparelho de quem a usa. Cada módulo transforma uma seção deste guia em ferramenta de trabalho:

Quadro 18 – Módulos da aplicação interativa

MÓDULO	PARA QUE SERVE	SEÇÃO DO GUIA
Método	Compromissos, regras de ouro, os dois instrumentos e um teste de escolha do instrumento certo	Como usar; Instrumentos de leitura
Ciclo	Cada fase com pergunta-guia, passos, sinal de alerta, erros a evitar e checklist do ciclo	F1 a F5
Leitor de sinais	Aplica a matriz de leitura de sinais sobre o mapa da cartografia social, indica quem age primeiro e gera a pergunta para a SCS	F2

MÓDULO	PARA QUE SERVE	SEÇÃO DO GUIA
Alerta 72 h	Relógio de cada alerta crítico, com o próximo passo, o escalonamento e o cálculo de V6	F4
Triagem	As quatro perguntas que definem o registro de ação, o prazo e o indicador	F4
Visibilização	Acompanha cada invisibilidade da identificação à devolução, com o cálculo de V5	F4
Reunião SCS	Relógio dos sete blocos, presença por segmento, retorno, contestações, Matriz UIC, encaminhamentos e ata	F3
Painel PVI	Aplica metas, leitura e gatilhos aos nove indicadores	Painel de Vigilância Integrada
Agenda	Distribui os ritmos a partir do início do ciclo e do dia fixo da reunião	Calendário operacional
Papéis, Governança, Implantação, Riscos	Consulta por ator, simulador de escalonamento, checklist de prontidão e modo contingência	Seções correspondentes

A aplicação é instrumento de apoio e de formação. Ela não substitui a Plataforma Ágora, e nela não se registram dados nominais de saúde.

16.1 Parâmetros a pactuar no ciclo inaugural

Quadro 19 – Parâmetros a pactuar no ciclo inaugural

PARÂMETRO	PROPOSTA DO PROTOCOLO	QUEM PACTUA
Metas do PVI (V3 a V9)	Mínima e recomendada conforme o Painel	SCS e gestão
Agravos prioritários e categorias de alerta	Definidos pelo Plano Popular	SCS, com APS e vigilância
Janela de antecipação (V4)	30 dias, mesma microárea, categoria compatível	Vigilância em Saúde e CTIS
Prazo de resposta a alertas críticos	72 horas a partir da hora zero	SCS, UBS e vigilância, por escrito
Entrega do relatório de dados	Antes da reunião, em linguagem legível	Dupla e técnico de dados
Dia fixo da reunião e semana-tipo	Cada SCS fixa os seus	SCS
Segmentos comunitários acompanhados em V9	Os do mapa sociométrico da Etapa 1	SCS